

Pr H.Benabderrahmane
Faculté de medecine Université Constantine3
Service Medecine interne CHU Constantine

Douleurs Thoraciques

Selon le programme national 3eme année Médecine
Année universitaire 2025-2026

Objectifs du cours

- 1 - Distinguer une douleur thoracique d'origine cardiaque d'une douleur d'origine thoracique.
- 2 -Préciser les caractéristiques sémiologiques d'une douleur de la dissection de l'aorte.
- 3 -Préciser les caractéristiques sémiologiques d'une douleur de l'embolie pulmonaire.
- 4- Préciser les caractéristiques sémiologiques des precordialgies

Plan du Cours

- 1-Introduction
- 2-Diagnostic positif
 - Interrogatoire
 - Examen clinique
 - Examens complémentaires
- 3-Diagnostic étiologique
- 4-Conclusion
- 5-Références

**Selon le programme national 3eme année Médecine
Année universitaire 2025-2026**

1-Introduction

La douleur thoracique représente le motif le plus fréquent de consultation en cardiologie .Les étiologies sont diverses organiques ou fonctionnelles.

L'anamnèse, l'examen clinique et certains examens complémentaires pourront orienter vers l'étiologie

Il faut, en priorité, savoir diagnostiquer 3 urgences : l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire et la dissection aortique.

2-Diagnostic Positif

•Interrogatoire

Il doit rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels du patient, ses antécédents familiaux cardiovasculaires, ses facteurs de risque cardiovasculaires, son traitement actuel et les caractéristiques de la douleur

Parmi les caractéristiques de la douleur, il faut déterminer :

- **date de début** de la douleur et sa **fréquence de survenue** permettant de distinguer une douleur aiguë et chronique
- les **circonstances d'apparition** (repos, effort, postprandiale, changements de position, à la toux, à l'inspiration, à la pression du thorax
- le **siège** de la douleur (rétrosternal, basi ou latéro thoracique, en hémi-ceinture,rétroscapulaire, épigastrique)
- le **type** de douleur :brûlure, pesanteur, constriction, pointe, crampe
- les **facteurs aggravants ou antalgiques** :position, effort, repos, antalgiques simples
- **l'irradiation ou migration** :ascendante, descendante, en hémi-ceinture, irradiant à la mâchoire, à l'omoplate ou aux bras
- sa **durée**: brève ou prolongée
- les **signes associés** : fièvre, dyspnée, toux, expectoration, hémoptysie, pyrosis, nausées, vomissements...)

▪Examen clinique

La première étape de l'examen clinique est de vérifier l'absence de signes de détresse vitale : détresse respiratoire, cyanose, état de choc et troubles de la conscience. Ceci sera recherché grâce :

- Un examen cardiovasculaire complet avec prise de la tension artérielle aux 4 membres : recherche d'une asymétrie tensionnelle évocatrice d'une dissection aortique.
- Une auscultation pulmonaire
- la recherche de signes de phlébite.

▪Examens complémentaires

Les principaux examens sont : ECG et radiographie du thorax

D'autres examens complémentaires seront demandés en fonction des hypothèses diagnostiques retenues à ce stade après ces 2 étapes

Ces examens sont :

- Examens d'imagerie : angioscanner, scintigraphie pulmonaire voire coronarographie
- Examens biologiques : gazométrie, enzymes cardiaques et D-dimères

3-Diagnostic Etiologique

Les douleurs décrites par le patient peuvent être d'origine organiques (liées à une pathologie sous jacente) ou être anorganiques (sans pathologie sous jacente)

► Etiologies des douleurs thoraciques organiques

■Douleurs thoraciques d'origine cardiovasculaires

1. L'angor :

Est du à une **inadéquation entre les besoins en oxygène et le débit coronaire et traduit l'ischémie myocardique.**

Cette inadéquation est secondaire le plus souvent à des sténoses coronariennes d'origine athéromateuses réduisant le débit sanguin coronaire.

► Définitions sémiologiques

▪ **L'angor typique** se présente sous la forme d'une douleur, gêne à type de constriction (serrement en étau) parfois de brûlure de localisation rétrosternale ou en barre médiosternale.

--Le patient la présente en appliquant la paume de sa main sur la partie antérieure de son thorax ou en plaçant ses deux mains de part et d'autre de sa cage thoracique en mimant un mouvement de compression.

Il peut aussi présenter un signe évocateur : « le signe de Levine » en portant son poing serré sur son thorax pour décrire la douleur constrictive

--La douleur peut rester localisée mais souvent irradie de façon ascendante vers la mâchoire ou l'épaule et le bras gauche. Elle peut aussi irradier aux deux bras et aux omoplates.

--La crise d'angor est de durée brève moins de 15 minutes et cède spontanément à l'arrêt des circonstances l'ayant déclenché ou après prise de trinitrine sublinguale.

--L'angor peut aussi se manifester de manière plus atypique par une blockpnée d'effort voire des manifestations digestives (éructations, vomissements, épigastralgies) ce qui rend le diagnostic plus difficile

--On distingue en fonction des circonstances d'apparition

-L'angor d'effort :

Les besoins en oxygène myocardique dépendent de 3 paramètres fréquence cardiaque, la force de contractilité et la tension pariétale du ventricule gauche. Lors d'un effort ils augmentent induisant une augmentation des besoins en oxygène non compensés du fait d'une augmentation insuffisante du débit coronaire lié dans la majorité des cas à la présence de sténoses coronaires athéromateuses.

-La douleur apparaît pour un effort constant déterminant le seuil ischémique. Il peut s'agir d'efforts de marche ou de montée d'escaliers et est favorisée par le stress, le froid, la marche en côte ou contre le vent.

Elle apparaît à l'effort et régresse 2-3 minutes après l'arrêt de celui-ci ou l'utilisation de trinitrine qui par son mécanisme vasodilatateur permet d'augmenter le débit coronaire.

L'angor de repos est la conséquence d'une diminution primitive du débit coronaire sans augmentation des besoins en oxygène. Il résulte :

- soit de spasmes coronariens (vasoconstriction) survenant sur des artères angiographiquement saines (angor dit de Prinzmetal)
- soit de rétrécissements coronariens liés à des plaques d'athéromateuses

Il est de moins bon pronostic que l'angor d'effort et nécessite une prise en charge adaptée rapide.

► Définitions syndromiques

▪ **L'angor stable** survient à l'effort, est confirmé par des modifications de l'ECG au cours d'un effort pour un seuil ischémique défini (épreuve d'effort, scintigraphie myocardique) et nécessite dans un premier temps la correction des facteurs de risque cardiovasculaires et la mise en place d'un traitement anti-ischémique médicamenteux.

Il résulte de la présence de plaques athéromateuses stables. De manière simplifiée, un angor stable est un angor stable dans le temps et pour le même niveau d'effort. Ainsi si les crises deviennent plus fréquentes ou plus longues ou pour des niveaux moindres, on parle **d'angor instable**.

▪ **L'angor instable** regroupe l'ensemble des formes cliniques d'angor pouvant évoluer en quelques heures, jours ou semaines vers un infarctus du myocarde constitué. Son mécanisme habituel est une rupture d'une plaque d'athérome devenue instable avec constitution d'un thrombus non occlusif réduisant significativement la lumière de l'artère.

Sa présentation clinique peut-être :

- **un angor de repos**

- **angor de novo** : chez un patient qui était jusque là asymptomatique , survenue d'un angor d'effort fréquent et invalidant pour des efforts minimes ou d'emblée un angor de repos

- **angor crescendo** : angor survenant pour des efforts de plus en plus minimes et cédant plus lentement

- **un angor post-infarctus**.

▪ **Dans l'infarctus du myocarde (IDM)**, la rupture de la plaque athéromateuse se complique d'un thrombus occlusif intracoronaire.

La douleur est de type angineuse, survenant particulièrement au repos, prolongée, intense, résistante à la trinitrine (trinitrorésistante), anxiogène et fréquemment accompagnée de nausées, vomissements, sueurs, lipothymies...

C'est une **urgence vitale** (désobstruction artérielle la plus rapide possible) du fait du risque de troubles rythmiques ventriculaires graves et de mort subite.

Selon les recommandations de l'ESC 2007 (European Society of Cardiology), on distingue actuellement 3 entités bien distinctes :

- L'angor stable
- Le syndrome coronaire aigu
- L'infarctus du myocarde

▪ **Le syndrome coronaire (SCA)** regroupe plusieurs entités qui sont :

- **Syndrome coronaire avec sus-décalage du segment ST** ou « **SCA ST+** »
- **Syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST** ou « **SCA non ST+** » en cas de douleur thoracique avec modifications électriques suspectes mais sans sus-décalage du segment ST et/ou avec élévation de la Troponine
- **Angor instable** en cas de douleur thoracique suspecte sans modifications électriques et sans élévation de la Troponine.

▪ **L'infarctus du myocarde** repose sur certains critères bien spécifiques :

Augmentation des marqueurs biologiques cardiaques (Troponine) associée à un des critères ci-dessous :

- symptômes d'ischémie
- modifications du segment ST, ou négativation des ondes T, ou apparition d'un bloc de branche gauche
- apparition d'ondes Q à l'ECG
- mise en évidence par imagerie de l'absence de viabilité d'un segment du myocarde (IRM, scintigraphie myocardique, échographie de stress) ou anomalie de la cinétique pariétale ventriculaire (échographie cardiaque).

Enfin l'**angor** peut-être **fonctionnel** c'est à dire lié à une souffrance myocardique par augmentation des besoins en oxygène sans lésions coronariennes sous-jacentes comme dans le cas de cardiopathies valvulaires, troubles du rythme supraventriculaires etc..

2. La péricardite aiguë est une inflammation du péricarde

Peut entraîner des douleurs médio-thoraciques pouvant être d'allure angineuse mais survenant au repos, majorées par l'inspiration profonde et le décubitus dorsal améliorées par l'antéflexion

L'examen clinique peut mettre en évidence un frottement péricardique (signe rappelant le crissement de cuir neuf) survenant à chaque cycle cardiaque et persistant en apnée. Ce signe pathognomonique est fugace et inconstant.

3. L'embolie pulmonaire

Est une obstruction partielle ou complète d'une artère pulmonaire ou de ses branches par un thrombus provenant souvent des veines des membres inférieurs.

- La douleur est latéro ou basithoracique, brutale, à type de point de côté, dyspnéisante, anxiogène et majorée à l'inspiration

- Elle survient dans un contexte évocateur : alitement, postopératoire, post-partum, thrombose veineuse profonde, antécédents thromboemboliques

- s'accompagne souvent de toux, de polypnée voire de lipothymies ou syncope en cas d'embolie pulmonaire massive

4. La dissection aortique

Est une déchirure de la paroi aortique.

- La douleur est brutale, thoracique antérieure ou postérieure, parfois transfixiante, intense avec paroxysmes douloureux, d'irradiation dorsale, migratrice, prolongée et trinitro-résistante.

- Pour évoquer ce diagnostic : rechercher des antécédents d'HTA, un souffle diastolique et une asymétrie tensionnelle (20mm Hg)

■ Douleurs thoraciques d'origine pleuro-pulmonaires

- Elles sont principalement basithoraciques augmentées à l'inspiration, associées à une dyspnée et de la toux.

-Les principales étiologies sont : l'embolie pulmonaire, les pneumopathies aiguës infectieuses, les pneumothorax et les pleurésies.

■ Douleurs thoraciques d'origine digestives et hépatiques

-**Le reflux gastro-oesophagien** : la douleur est à type de brûlure, rétrosternale, ascendante et majorée à l'antéflexion.

-**Le spasme oesophagien** : la douleur peut simuler une douleur angineuse, elle est brève, non rythmée par les efforts et déclenchée par la déglutition

- **L'ulcère gastro-oesophagien** : la douleur est souvent épigastrique à type de crampe, postprandiale tardive soulagée par les repas et les pansements gastriques.

- **La pancréatite aiguë** : la douleur est intense, épigastrique, transfixiante permanente soulagée par le jeûne.

-**La colique hépatique** :

ces douleurs hépatiques peuvent être liées à une cause hépatobiliaire (calculs biliaires) mais peuvent aussi être en rapport avec une insuffisance cardiaque se compliquant d'hépatalgies

■ Douleurs thoraciques pariétales

Ce sont des douleurs reproduites à la pression du grill costal, non rythmées par les efforts, de durée variable souvent à type de pointe. Elles peuvent être déclenchées par un mouvement de bras ou de tête.

Le syndrome de Tietze, bénin, est une douleur de l'articulation chondrocostale ou sterno-claviculaire et est reproduite à la pression de ces articulations

■ Douleurs neurologiques

On retrouve : le zona et les hernies discales cervicales ou thoraciques

► Douleurs thoraciques anorganiques

Il s'agit d'un diagnostic d'exclusion

il faudra l'évoquer seulement après avoir éliminé toutes les causes de douleurs organiques

Certains critères anamnestiques, cliniques ou paracliniques pourront aider à poser ce diagnostic:

- à l'interrogatoire :

- patient jeune sans facteurs de risque cardiovasculaires, contexte de stress ou d'anxiété.

- par les caractéristiques de la douleur telles : reproduite à la palpation, prolongée sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, survenant dans un contexte de stress, de topographie très localisée sous mammaire ou au contraire diffuse de localisation imprécise et survenant au repos sans conséquence sur l'activité physique du patient

- par l'absence d'anomalies à l'examen clinique

- Par l'absence d'anomalies de l'ECG) et de la radiographie pulmonaire

4-Conclusion

La douleur thoracique est un motif de consultation fréquent aux urgences médicales. Les étiologies sont nombreuses d'origine cardiovasculaire ou d'une autre origine pleuropulmonaire, hépatique, neurologique etc.

Dans un premier temps, il est primordial d'éliminer une urgence vitale (dissection aortique, embolie pulmonaire et infarctus du myocarde) puis on pourra rechercher les autres causes organiques de cette douleur thoracique.

Enfin si l'enquête étiologique ne révèle aucune cause organique, il sera possible d'évoquer les causes inorganiques.

5-Références

1- Collège des Enseignants de Pneumologie. Orientation Diagnostique devant une Douleur Thoracique aiguë et chronique. 2013

2- Collège National des Enseignants de Cardiologie (CNEC) et la Société Française de Cardiologie (SFC). Douleur thoracique aiguë et chronique. 2014

3- La Combe, B. et Borie, R. Douleurs thoraciques. 2012.